



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 77

Ausgegeben zu Dresden am

12. September 2026

Inhaltsverzeichnis

12. September 2026

**Besonderes Gesetz über Wohnen,
Gesundheit und Pflege im Freistaat
Ostdeutschland und zur Änderung
weiterer Vorschriften**

Seite 2

Besonderes Gesetz
über Wohnen, Gesundheit und Pflege im Freistaat
Ostdeutschland und zur Änderung weiterer
Vorschriften
vom 12. September 2026

Die Volkskammer hat am 11. September 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

**Einführung eines besonderen
Gesetzes über die Gewährleistung
von Wohnen, Gesundheit und Pflege**

**Besonderes Gesetz über die
Gewährleistung von Wohnen,
Gesundheit und Pflege
(Soziale Grundversorgungsgesetz –
SoGrVG)**

**Abschnitt 1
Bedarfsplanung und
Versorgungssicherung**

§ 1

Fachteil Soziale Grundversorgung

- (1) Der Landesrahmenplan der öffentlichen Daseinsvorsorge nach § 12 des Ostdeutschen Daseinsvorsorgegesetzes enthält

für die Bereiche Wohnen, Gesundheit, Pflege und öffentlicher Gesundheitsdienst einen besonderen Fachteil Soziale Grundversorgung.

- (2) Der Fachteil enthält mindestens
1. eine zusammenfassende Bewertung der Versorgungslage in den Bereichen Wohnen, Gesundheit, Pflege und öffentlicher Gesundheitsdienst,
 2. eine Darstellung regionaler Versorgungsunterschiede,
 3. die Entwicklung des Bedarfs unter Berücksichtigung von Bevölkerung, Altersstruktur, Morbidität, Pflegebedarf, Haushaltsstruktur,

- Einkommen,
Siedlungsstruktur und
Erreichbarkeit,
4. die nach § 3 geltenden
Mindestversorgungsstandards,
 5. die festgestellten oder
drohenden regionalen
Unterdeckungen,
 6. die zur Sicherung der
Versorgung vorgesehenen
landesweiten und
regionalen Maßnahmen,
 7. die Entwicklung
öffentlicher und
gemeinwohlgebundener
Trägerschaft,
 8. die erforderliche
Abstimmung zwischen
Krankenhausversorgung,
Pflege, öffentlichem
Gesundheitsdienst und
sonstiger
Gesundheitsinfrastruktur
und
 9. die für den
Planungszeitraum
vorgesehenen
Schwerpunkte der
Landesförderung.
- (3) Der Entwurf des Fachteils ist den
Bezirken, den kommunalen
Spitzenverbänden und den nach

- § 27 zu beteiligenden Stellen zur
Stellungnahme zuzuleiten. Die
Stellungnahmefrist beträgt
mindestens acht Wochen.
- (4) Der Fachteil und seine
wesentlichen Datengrundlagen
werden veröffentlicht.
- (5) Die für die soziale
Grundversorgung geltenden
verbindlichen Vorgaben des
Gesellschafts- und
Wirtschaftsplans nach Artikel 13b
der Ostdeutschen
Staatsverfassung sind zu
beachten. Der Fachteil ist mit
ihnen sowie mit den sonstigen
übergeordneten Fach- und
Entwicklungsplanungen des
Freistaates abzustimmen. Eine
doppelte Planung und
Berichterstattung ist zu
vermeiden.

§ 2

Regionale Versorgungsberichte

- (1) Jeder Bezirk erstellt jeweils alle
zwei Jahre einen regionalen
Versorgungsbericht für sein
Gebiet.
- (2) Der Bericht enthält mindestens
1. die regionalen Ergebnisse
des
Versorgungsmonitorings,

2. bestehende und absehbare Versorgungsengpässe,
3. die Entwicklung öffentlicher und gemeinwohlgebundener Kapazitäten,
4. die Ergebnisse kommunaler Wohnraum- und Pflegeinfrastrukturplanungen,
5. die für den Bezirk bedeutsamen Krankenhausstandorte,
6. die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes und
7. Empfehlungen für Maßnahmen des Freistaates, der kommunalen Ebene und öffentlicher oder gemeinwohlgebundener Träger.

§ 3

Regionale

Mindestversorgungsstandards

- (1) Für die Wahrnehmung der Gewährleistungsverantwortung

- werden durch Rechtsverordnung regionale Mindestversorgungsstandards festgelegt. Sie konkretisieren für die von diesem Gesetz erfassten Bereiche die Gewährleistungen der Artikel 7a und 7b der Ostdeutschen Staatsverfassung.
- (2) Die Mindestversorgungsstandards müssen geeignete und überprüfbare Maßstäbe enthalten für
 1. die quantitative Verfügbarkeit, dauerhafte Sicherung und Bezahlbarkeit von Wohnraum,
 2. die Erreichbarkeit und dauerhafte Verfügbarkeit von Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung sowie anderer für die Krankenhausplanung wesentlicher Standorte und Leistungsbereiche,
 3. die regionale Verfügbarkeit notwendiger Pflegeinfrastruktur einschließlich ambulanter, teilstationärer, Kurzzeit- und stationärer Angebote,

- 4. die Erreichbarkeit von Angeboten der Gemeindepflege und
 - 5. die personelle, organisatorische und räumliche Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes.
- (3) Bei der Festlegung sind unterschiedliche Siedlungs-, Verkehrs- und Bevölkerungsstrukturen zu berücksichtigen. Für dünn besiedelte Räume können andere geeignete Maßstäbe als für verdichtete Räume bestimmt werden, sofern ein gleichwertiges Versorgungsniveau gewährleistet bleibt.
- (4) Die Mindestversorgungsstandards binden die landesrechtliche Planung, Förderung, Organisation und Gewährleistung.

§ 4

Versorgungsmonitoring

- (1) Die jeweils fachlich zuständigen Staatssekretariate führen für ihre Geschäftsbereiche ein

- fortlaufendes Versorgungsmonitoring durch.
- (2) Hierfür sind vorrangig Daten zu verwenden, die öffentlichen Stellen aufgrund bestehender gesetzlicher Melde-, Statistik- oder Berichtspflichten bereits vorliegen.
- (3) Öffentliche und gemeinwohlgebundene Träger, die institutionell oder strukturell durch den Freistaat gefördert werden, übermitteln die für das Monitoring erforderlichen nicht personenbezogenen Angaben, soweit diese nicht bereits auf anderer Grundlage verfügbar sind.
- (4) Personenbezogene Gesundheits-, Pflege- oder Mietdaten dürfen aufgrund dieses Gesetzes nicht erhoben werden. Statistische Angaben sind so zu verarbeiten und zu veröffentlichen, dass Rückschlüsse auf einzelne Personen ausgeschlossen sind.
- (5) Die wesentlichen Ergebnisse des Monitorings werden mindestens jährlich veröffentlicht.
- (6) Die Ergebnisse des Versorgungsmonitorings sind für die Beobachtung und Bewertung der Versorgungslage nach § 3

Absatz 2 Nummer 1 des
Ostdeutschen
Daseinsvorsorgegesetzes und für
den Landesrahmenplan nach § 12
des Ostdeutschen
Daseinsvorsorgegesetzes zu
verwenden. Eine gesonderte
Erhebung derselben Daten ist zu
vermeiden.

§ 5

Feststellung einer Unterdeckung

- (1) Ergeben sich aus dem
Monitoring konkrete
Anhaltspunkte für eine
bestehende oder drohende
regionale Unterdeckung, prüft
das fachlich zuständige
Staatssekretariat unverzüglich, ob
eine solche Unterdeckung
vorliegt.
- (2) Eine Prüfung ist auch auf Antrag
einzuleiten. Antragsberechtigt
sind
 1. die Bezirke,
 2. die kommunalen
Gebietskörperschaften des
Ostdeutschen Freistaates,
 3. öffentliche oder
gemeinwohlgebundene
Träger einer betroffenen
versorgungsnotwendigen
Einrichtung und

4. gesetzlich oder
satzungsmäßig gebildete
Vertretungsorgane der
Nutzer oder Beschäftigten
einer unmittelbar
betroffenen öffentlichen
Einrichtung.

- (3) Der Antrag muss Tatsachen
bezeichnen, die eine bestehende
oder drohende Unterdeckung
nachvollziehbar erscheinen
lassen.
- (4) Vor der Entscheidung sind die
betroffenen kommunalen
Gebietskörperschaften und
Fachplanungsträger sowie, soweit
erforderlich, öffentliche oder
gemeinwohlgebundene Träger zu
beteiligen.
- (5) Die zuständige Stelle entscheidet
durch begründeten Bescheid.
Die Entscheidung soll innerhalb
von drei Monaten nach Vorliegen
der für die Prüfung
erforderlichen Angaben ergehen.
Bei einer unmittelbar
bevorstehenden erheblichen
Versorgungsbeeinträchtigung ist
unverzüglich zu entscheiden.
- (6) Wird eine Unterdeckung oder
drohende Unterdeckung
festgestellt, ist § 6 anzuwenden.

- (7) Eine bestehende oder drohende regionale Unterdeckung nach diesem Gesetz gilt zugleich als erhebliche Versorgungslücke im Sinne des Ostdeutschen Daseinsvorsorgegesetzes.

§ 6

Versorgungssicherungsplan und gleichwertiger Ersatz

- (1) Nach einer Feststellung gemäß § 5 erstellt das zuständige Staatssekretariat unverzüglich einen Versorgungssicherungsplan.
- (2) Der Versorgungssicherungsplan bestimmt mindestens
1. das betroffene Gebiet und den betroffenen Versorgungsbereich,
 2. Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Unterdeckung,
 3. die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen,
 4. die für deren Durchführung verantwortlichen Stellen,
 5. den Zeitplan,
 6. die erforderlichen Finanzierungs- oder Förderinstrumente und
7. die Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit.
- (3) Vorrangig sind vorhandene fachgesetzliche Planungs-, Förder-, Sicherungs- und Organisationsinstrumente einzusetzen. Neue Einrichtungen oder Sondervermögen dürfen nur errichtet werden, wenn die vorhandenen Instrumente zur dauerhaften Sicherung der Versorgung nicht ausreichen.
- (4) Soll eine bestehende öffentliche Einrichtung oder ein wesentlicher Teil ihrer Versorgungsleistung aufgegeben oder dauerhaft erheblich vermindert werden, hat die zuständige Stelle vor der Entscheidung festzustellen,
1. ob zwingende Gründe des Gemeinwohls vorliegen und
 2. durch welche konkrete Maßnahme gleichwertiger Ersatz gewährleistet wird.
- Der Ersatz muss grundsätzlich spätestens mit Wirksamwerden des Abbaus zur Verfügung stehen.
- (5) Absatz 4 gilt nicht für kurzfristige Einschränkungen infolge

unvorhersehbarer Notfälle. In diesen Fällen sind unverzüglich geeignete Übergangsmaßnahmen zu treffen.

- (6) Die Absätze 1 bis 5 konkretisieren für die von diesem Gesetz erfassten Bereiche Artikel 7a Absatz 3 Satz 2 der Ostdeutschen Staatsverfassung und § 17 des Ostdeutschen Daseinsvorsorgegesetzes.

Abschnitt 2

Wohnen

§ 7

Wohnraumbedarfsplanung

- (1) Das für Wohnungswirtschaft zuständige Staatssekretariat führt auf Grundlage kommunaler und regionaler Daten eine landesweite Wohnraumbedarfsplanung durch. Sie ist Bestandteil des Landesrahmenplans.
- (2) Bei der Wohnraumbedarfsplanung sind insbesondere zu berücksichtigen
1. Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung,
 2. Haushaltsgrößen,

3. Einkommen und Wohnkostenbelastung in statistisch zusammengefasster Form,
 4. Wohnungsbestand und Leerstand,
 5. Neubau-, Rückbau- und Umwandlungsentwicklung,
 6. der Bestand an öffentlich, sozial oder sonst gemeinwohlgebundenen Wohnungen,
 7. Barrierefreiheit und altersgerechter Wohnraum,
 8. besondere Bedarfe von Familien, älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen, Auszubildenden, Studierenden und sonstigen Gruppen mit erschwertem Zugang zum Wohnungsmarkt,
 9. räumliche Erreichbarkeit sozialer Infrastruktur und
 10. absehbare regionale Strukturveränderungen.
- (3) Die Bedarfsplanung trifft keine Festsetzungen über die nach bürgerlichem Recht zulässige Miethöhe.

§ 8**Öffentliche und
gemeinwohlgebundene
Wohnungsbestände**

- (1) Der Freistaat richtet seine Wohnungs-, Liegenschafts-, Beteiligungs- und Förderpolitik darauf aus, öffentliche und dauerhaft gemeinwohlgebundene Wohnungsbestände zu erhalten und bedarfsgerecht zu mehren.
- (2) Öffentliche Wohnungsunternehmen und die Anstalt öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“ berücksichtigen im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben und ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit die nach diesem Gesetz festgestellten regionalen Wohnraumbedarfe bei
 1. Neubau,
 2. Erwerb,
 3. Instandhaltung,
 4. Modernisierung,
 5. barrierearmem oder barrierefreiem Umbau und
 6. langfristiger Bestandsentwicklung.
- (3) Der Freistaat unterstützt Gemeinden und kommunale Wohnungsunternehmen bei der Erhaltung, Erweiterung und

Neuschaffung dauerhaft
gemeinwohlgebundener
Wohnungsbestände.

§ 9**Kommunale Wohnraumversorgung**

- (1) Gemeinden mit festgestellter bestehender oder drohender Wohnraumunterdeckung erstellen ein Wohnraumversorgungskonzept oder schreiben ein bestehendes Konzept fort.
- (2) Mehrere Gemeinden können ein gemeinsames Wohnraumversorgungskonzept erstellen.
- (3) Soweit bereits ein nach Wohnraumförderungs-, Bauplanungs- oder sonstigem Landesrecht erforderliches Konzept die Anforderungen der Absätze 1 und 2 erfüllt, ist kein zusätzliches Konzept erforderlich.

§ 10**Instrumente der
Wohnraumversorgung**

- (1) Zur Beseitigung oder Verhinderung einer Wohnraumunterdeckung können insbesondere eingesetzt werden

1. die soziale Wohnraumförderung,
2. die Förderung kommunaler oder gemeinwohlgebundener Wohnungsunternehmen,
3. Neubau- und Erwerbsmaßnahmen öffentlicher Wohnungsunternehmen,
4. Maßnahmen der Anstalt öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“ im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben,
5. Grundstücke des Landesbodenfonds und sonstige öffentliche Grundstücke,
6. Erbbaurechte und andere langfristig gemeinwohlgebundene Grundstücksüberlassungen,
7. der Ankauf von Belegungs- oder Mietpreisbindungen nach Maßgabe des Wohnraumförderungsrechts und
8. zulässige städtebauliche und bodenrechtliche Instrumente.

- (2) Die Auswahl eines Instruments richtet sich nach seiner Eignung zur dauerhaften, wirtschaftlichen und sozialen Sicherung des festgestellten Bedarfs.

§ 11

Schutz vor Wohnungslosigkeit

- (1) Die zuständigen öffentlichen Stellen des Freistaates und der kommunalen Träger stellen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten sicher, dass niemand infolge einer staatlichen Maßnahme oder der Vollstreckung eines Räumungstitels wohnungslos wird.
- (2) Wird einer zuständigen Stelle bekannt, dass einer Person infolge einer unmittelbar bevorstehenden Räumung Wohnungslosigkeit droht, hat sie unverzüglich die zur Vermeidung der Wohnungslosigkeit erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Kann der bisherige Wohnraum nicht erhalten oder rechtzeitig anderer Wohnraum vermittelt werden, ist spätestens mit Eintritt des Wohnungsverlustes eine menschenwürdige Unterkunft sicherzustellen.

- (3) Bei der Unterbringung sind insbesondere die persönlichen und familiären Verhältnisse, gesundheitliche Beeinträchtigungen, Behinderungen, Pflegebedürftigkeit sowie die Belange minderjähriger Kinder angemessen zu berücksichtigen. Eine Unterbringung im bisherigen sozialen Umfeld ist anzustreben, soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
- (4) Die zuständigen kommunalen Stellen, Wohnungsbehörden, Sozialbehörden und sonstigen Landesbehörden arbeiten zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit zusammen. Personenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet und übermittelt werden, soweit eine gesetzliche Grundlage besteht und dies für die Vermeidung unmittelbar drohender Wohnungslosigkeit erforderlich ist.
- (5) Dieses Gesetz begründet keine Befugnis, eine nach Bundesrecht zulässige Zwangsvollstreckung auszusetzen oder aufzuheben.

Abschnitt 3

Gesundheit und Krankenhäuser

§ 12

Gewährleistung der Gesundheitsversorgung

- (1) Der Freistaat gewährleistet im Rahmen seiner Zuständigkeiten eine wohnortnahe, bedarfsgerechte und gemeinwohlorientierte Gesundheitsversorgung. Der Zugang zur medizinischen Grundversorgung darf nicht von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Einzelnen abhängen.
- (2) Bei landesrechtlichen Planungs-, Förder- und Organisationsentscheidungen sind insbesondere zu berücksichtigen
1. Krankenhausversorgung,
 2. Notfall- und Rettungsstrukturen, soweit landesrechtlich geregelt,
 3. öffentlicher Gesundheitsdienst,
 4. landeseigene und kommunale Gesundheitsangebote,
 5. Prävention und Gesundheitsförderung,

6. sektorenübergreifende Versorgungsstrukturen, soweit Landesrecht hierfür Zuständigkeiten eröffnet,
 7. psychiatrische und psychotherapeutische Versorgungsstrukturen im landesrechtlichen Zuständigkeitsbereich,
 8. Kinder- und Jugendgesundheit und
 9. regionale Erreichbarkeit.
- (3) Erkenntnisse über Defizite der vertragsärztlichen Versorgung sind den nach Bundesrecht zuständigen Stellen zuzuleiten und in den bundesrechtlich vorgesehenen Beteiligungs- und Beanstandungsverfahren geltend zu machen.

§ 13

Krankenhausversorgung

- (1) Die Krankenhausplanung ist das vorrangige Instrument zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten stationären Versorgung. Sie richtet sich nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Ostdeutschen Krankenhausgesetz.

- (2) Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung im Sinne dieses Gesetzes sind die in den Krankenhausplan aufgenommenen Krankenhausstandorte und Leistungsstrukturen, denen nach der Krankenhausplanung eine für die regionale Grund- oder Regelversorgung wesentliche Funktion zukommt.
- (3) Bei der Krankenhausplanung sind die regionalen Mindestversorgungsstandards nach § 3 und Feststellungen einer bestehenden oder drohenden Unterdeckung nach § 5 im Rahmen des bundes- und landesrechtlich Zulässigen zu berücksichtigen.

§ 14

Sicherung versorgungsnotwendiger Krankenhausstandorte

- (1) Wird für einen Krankenhausstandort oder Leistungsbereich eine bestehende oder drohende regionale Unterdeckung festgestellt, sind unverzüglich die nach dem Ostdeutschen Krankenhausgesetz vorgesehenen

- Planungs- und
Sicherungsverfahren einzuleiten.
- (2) Liegen zugleich Anhaltspunkte
für eine wirtschaftliche oder
trägerbezogene Gefährdung
eines versorgungsnotwendigen
Standortes oder
Leistungsbereiches vor, ist zu
prüfen, ob Maßnahmen nach
dem Ostdeutschen
Krankenhaussicherungs- und
Rekommunalisierungsfondsgesetz
einzuleiten sind.
- (3) Die Errichtung eines weiteren
Fonds oder einer parallelen
Sicherungseinrichtung aufgrund
dieses Gesetzes ist
ausgeschlossen, solange die
Sicherungsziele mit den
Instrumenten des Ostdeutschen
Krankenhaussicherungs- und
Rekommunalisierungsfonds
erreicht werden können.

§ 15

Demokratische Organisation öffentlicher Krankenhäuser

- (1) Krankenhäuser unter
beherrschendem öffentlichem
Einfluss sind so zu organisieren,
dass ihre Leitung und
strategische Entwicklung am
Versorgungsauftrag, am Wohl
- der Patienten, an den Belangen
der Beschäftigten und an einer
bedarfsgerechten regionalen
Versorgung ausgerichtet sind.
- (2) In den für die strategische
Leitung oder Überwachung
zuständigen Verwaltungs-,
Aufsichts- oder vergleichbaren
Organen sind die Beschäftigten
mit Stimmrecht zu vertreten. Die
Interessen der Patienten und
Nutzer sowie die betroffenen
kommunalen
Gebietskörperschaften sind in
geeigneter Weise an Leitung und
Kontrolle zu beteiligen.
Weitergehende gesetzliche
Mitbestimmungs- und
Beteiligungsrechte bleiben
unberührt.
- (3) Die Beteiligung nach Absatz 2
erstreckt sich insbesondere auf
grundlegende Entscheidungen
über
1. den Versorgungsauftrag,
 2. die Standort- und
Leistungsstruktur,
 3. die langfristige
Investitionsplanung,
 4. die Ausgliederung
wesentlicher
Leistungsbereiche und

5. grundlegende
Veränderungen der
Zugänglichkeit oder des
Leistungsangebots.

§ 16

Öffentliche und gemeinwohlgebundene Trägerschaft

- (1) Bei Maßnahmen des Freistaates zur Übernahme, Neugründung oder dauerhaften strukturellen Sicherung versorgungsnotwendiger Krankenhäuser ist eine öffentliche, kommunale, genossenschaftliche oder andere dauerhaft gemeinwohlgebundene Trägerschaft anzustreben.
- (2) Bei der Vergabe freiwilliger struktureller Landesförderung kann die dauerhafte Gemeinwohlbindung als Fördervoraussetzung oder Auswahlkriterium vorgesehen werden, soweit dies mit Bundesrecht und dem Recht der Europäischen Union vereinbar ist.
- (3) Weitergehende Bindungen nach dem Ostdeutschen Krankenhaussicherungs- und Rekommunalisierungsfondsgesetz bleiben unberührt.

§ 17

Öffentliche und gemeinwohlgebundene ambulante Versorgungsstrukturen

- (1) Besteht oder droht nach § 5 eine regionale Unterdeckung im Bereich der ambulanten gesundheitlichen Versorgung, unterstützt der Freistaat im Rahmen seiner Zuständigkeiten und der bundesrechtlichen Vorgaben die Errichtung und Erweiterung kommunaler sowie von zugelassenen öffentlichen Krankenhäusern oder anderen hierzu berechtigten gemeinwohlorientierten Trägern getragener Medizinischer Versorgungszentren und anderer gemeinwohlorientierter multiprofessioneller Versorgungsstrukturen.
- (2) Maßnahmen nach Absatz 1 können insbesondere umfassen
1. die Bereitstellung geeigneter öffentlicher Grundstücke und Räume,
 2. Investitions- und Anschubförderung,
 3. die Unterstützung kommunaler Träger bei Errichtung und Organisation,

4. die Einbeziehung öffentlicher Krankenhausträger,
 5. die Koordinierung mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst und der Gemeindepflege sowie
 6. die Förderung sektorenübergreifender und multiprofessioneller Versorgungsmodelle.
- (3) Soweit dies dem regionalen Bedarf entspricht, sollen solche Strukturen die Zusammenarbeit insbesondere von haus- und fachärztlicher Versorgung, Gemeindepflege, Psychotherapie, Gesundheitsförderung sowie Sozial- und Suchtberatung erleichtern.

Abschnitt 4

Pflege und Gemeindepflege

§ 18

Gewährleistung der Pflegeversorgung; Pflegeinfrastrukturplanung

- (1) Der Freistaat gewährleistet im Rahmen seiner Zuständigkeiten den Zugang zu einer

bedarfsgerechten pflegerischen Versorgung.

- (2) Zur Wahrnehmung der Aufgaben des Landes nach § 9 des Elften Buches Sozialgesetzbuch wird eine regional gegliederte Pflegeinfrastrukturplanung durchgeführt.
- (3) Die Landkreise und kreisfreien Städte erstellen für ihr Gebiet mindestens alle fünf Jahre einen Pflegeinfrastrukturplan und schreiben ihn bei wesentlichen Veränderungen fort.
- (4) Die Bezirke koordinieren die Pflegeinfrastrukturplanung in Angelegenheiten, die das Gebiet mehrerer Landkreise oder kreisfreier Städte betreffen, und wirken auf einen angemessenen regionalen Ausgleich hin.
- (5) Das für Gesundheits- und Sozialwesen zuständige Mitglied des Staatsrates fasst die regionalen Planungen zusammen und berücksichtigt sie im Fachteil Soziale Grundversorgung nach § 1.
- (6) Bestehende kommunale oder regionale Pflegeplanungen, die den Anforderungen dieses Gesetzes entsprechen, gelten als

Pflegeinfrastrukturplan im Sinne
des Absatzes 3..

§ 19

Inhalt der Pflegeinfrastrukturplanung

- (1) Die Pflegeinfrastrukturplanung umfasst insbesondere
1. die gegenwärtige und voraussichtliche Zahl pflegebedürftiger Menschen,
 2. die Alters- und Bevölkerungsentwicklung,
 3. vorhandene ambulante, teilstationäre, Kurzzeit- und stationäre Pflegeangebote,
 4. Angebote zur Unterstützung im Alltag,
 5. Beratungs-, Entlastungs- und Unterstützungsangebote für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige,
 6. Angebote der Gemeindepflege,
 7. barrierefreie und pflegegeeignete Wohnformen,
 8. die räumliche Erreichbarkeit der Angebote,

9. erkennbare Angebotslücken,
10. den investiven Entwicklungsbedarf und
11. Möglichkeiten öffentlicher, kommunaler, genossenschaftlicher oder anderer dauerhaft gemeinwohlgebundener Trägerschaft.

§ 20

Pflegestützpunkte

- (1) Das zuständige Staatssekretariat bestimmt nach § 7c Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch die Einrichtung eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Netzes von Pflegestützpunkten.
- (2) Zahl, räumliche Verteilung und Erreichbarkeit der Pflegestützpunkte sind mit der Pflegeinfrastrukturplanung nach den §§ 18 und 19 abzustimmen. Insbesondere sind die Bedürfnisse ländlicher und dünn besiedelter Räume zu berücksichtigen.
- (3) Der Freistaat wirkt im Rahmen der bundesrechtlichen Möglichkeiten

darauf hin, dass
Pflegestützpunkte eng mit den
kommunalen Beratungsstrukturen,
der Gemeindepflege, dem
öffentlichen Gesundheitsdienst
und den Angeboten für
pflegende Angehörige
zusammenarbeiten.

§ 21

Gemeindepflege

- (1) Gemeindepflege im Sinne dieses Gesetzes ist ein wohnortnahes, niedrighschwelliges öffentliches Angebot zur Prävention, Beratung, Begleitung und Vernetzung insbesondere für ältere, pflegebedürftige, chronisch kranke oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen und ihre Angehörigen.
- (2) Angebote der Gemeindepflege können insbesondere umfassen
1. aufsuchende Beratung und präventive Hausbesuche,
 2. Information über vorhandene Hilfs-, Pflege- und Gesundheitsangebote,

3. Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit zuständigen Beratungs- und Leistungsträgern,
 4. Koordinierung lokaler Unterstützungsnetzwerke,
 5. Unterstützung pflegender Angehöriger,
 6. Mitwirkung an einem geordneten Übergang zwischen Krankenhaus, Rehabilitation, Pflege und häuslicher Versorgung,
 7. Gesundheitsförderung und Prävention sowie
 8. frühzeitige Erkennung struktureller Versorgungslücken.
- (3) Landkreise und kreisfreie Städte gewährleisten im Zusammenwirken mit den Gemeinden einen angemessenen Zugang zu Angeboten der Gemeindepflege. Sie können die Aufgabe selbst, gemeinsam mit Gemeinden, durch andere öffentliche oder kommunale Träger, durch Genossenschaften oder durch geeignete andere dauerhaft gemeinwohlgebundene Träger erfüllen.

- (4) Der Freistaat unterstützt Aufbau und Betrieb der Gemeindepflege nach Maßgabe des Haushalts.

§ 22

Landesweites Pflegenottelefon

- (1) Der Freistaat gewährleistet ein landesweit erreichbares Pflegenottelefon zur Beratung und Vermittlung bei dringenden pflegerischen Versorgungslagen außerhalb der regelmäßigen Erreichbarkeit der örtlichen Beratungsstrukturen.
- (2) Das Pflegenottelefon hat insbesondere die Aufgabe,
1. bei plötzlich auftretenden pflegerischen Versorgungslagen erste Orientierung zu geben,
 2. an zuständige Pflege-, Beratungs-, Gesundheits- und Sozialstrukturen zu vermitteln,
 3. bei Ausfall einer häuslichen Pflegeperson die Suche nach kurzfristig verfügbaren Unterstützungs- oder Kurzzeitpflegeangeboten zu unterstützen und
 4. mit Pflegestützpunkten, Gemeindepflege,

kommunalen Stellen und vorhandenen Krisen- und Notdiensten zusammenzuarbeiten.

- (3) Das Pflegenottelefon ersetzt weder den Rettungsdienst noch ärztliche Notfalldienste und begründet keine über das Bundesrecht hinausgehenden Ansprüche auf Leistungen der Pflegeversicherung.
- (4) Der Betrieb kann einer geeigneten öffentlichen oder dauerhaft gemeinwohlgebundenen Stelle übertragen werden.

§ 23

Sicherung der Pflegeinfrastruktur

- (1) Wird eine bestehende oder drohende Unterdeckung der Pflegeinfrastruktur festgestellt, sind vorrangig Maßnahmen der bestehenden Pflege-, Investitions- und Strukturförderung einzusetzen.
- (2) Soweit diese Maßnahmen nicht ausreichen, kann der Freistaat im Rahmen seiner Zuständigkeiten insbesondere

1. Investitionen öffentlicher, kommunaler, genossenschaftlicher oder anderer dauerhaft gemeinwohlgebundener Träger fördern,
 2. die interkommunale Zusammenarbeit unterstützen,
 3. Grundstücke oder Einrichtungen für Pflegezwecke bereitstellen,
 4. die Errichtung oder Erweiterung öffentlicher, kommunaler, genossenschaftlicher oder anderer dauerhaft gemeinwohlgebundener Einrichtungen fördern und
 5. Modellvorhaben zur regionalen Versorgungssicherung unterstützen.
- (3) Bei der Wahl einer Trägerlösung sind öffentliche, kommunale, genossenschaftliche und andere dauerhaft gemeinwohlgebundene Lösungen nach ihrer Eignung zur dauerhaften, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Sicherung der Versorgung zu prüfen.

- (4) Droht die dauerhafte Aufgabe einer versorgungsnotwendigen Pflegeeinrichtung aus wirtschaftlichen oder trägerbezogenen Gründen, ist vor ihrer Aufgabe zu prüfen, ob die Versorgung durch Übernahme, Erwerb, Beteiligung, Pacht oder eine andere geeignete Überleitung auf einen öffentlichen, kommunalen, genossenschaftlichen oder anderen dauerhaft gemeinwohlgebundenen Träger gesichert werden kann. Der Freistaat kann eine solche Überleitung nach Maßgabe des Haushalts und des Rechts der Europäischen Union fördern.

Abschnitt 5

Öffentlicher Gesundheitsdienst

§ 24

Gewährleistung des öffentlichen Gesundheitsdienstes

- (1) Der Freistaat gewährleistet einen flächendeckend erreichbaren und dauerhaft handlungsfähigen öffentlichen Gesundheitsdienst.
- (2) Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes dürfen nur

aufgegeben oder in ihrer Leistungsfähigkeit dauerhaft wesentlich vermindert werden, wenn

1. zwingende Gründe des Gemeinwohls vorliegen und
2. eine gleichwertige Wahrnehmung der betroffenen Aufgaben rechtzeitig sichergestellt ist.

4. gesundheitlichen Schutz von Kindern und Jugendlichen,
5. erforderliche umweltbezogene und sozialmedizinische Aufgaben,
6. Krisen- und Katastrophenfähigkeit und
7. erforderliche bezirksübergreifende Unterstützung.

§ 25

Regionale Mindestleistungsfähigkeit

(1) Die Mindestversorgungsstandards nach § 3 müssen für den öffentlichen Gesundheitsdienst insbesondere gewährleisten

1. ausreichende örtliche Erreichbarkeit,
2. dauerhafte Wahrnehmungsfähigkeit der gesetzlich übertragenen Pflichtaufgaben,
3. Vorsorge für übertragbare Krankheiten und besondere gesundheitliche Gefahrenlagen,

Abschnitt 6

Beteiligung, Finanzierung und Kontrolle

§ 26

Regionale Grundversorgungskonferenzen

- (1) Die Bezirke führen mindestens einmal jährlich eine regionale Grundversorgungskonferenz durch.
- (2) Zu beteiligen sind insbesondere Vertreter:innen
 1. der kommunalen Gebietskörperschaften,
 2. der zuständigen Landesstellen,

3. öffentlicher und
gemeinwohlgebundener
Wohnungsunternehmen,
4. der Krankenhausträger,
5. der Pflegeinfrastruktur,
6. des öffentlichen
Gesundheitsdienstes,
7. der Nutzer- und
Patienteninteressen,
8. der Interessen
pflegebedürftiger
Menschen und ihrer
Angehörigen,
9. der Menschen mit
Behinderungen und
10. der Beschäftigten.

(3) Die Grundversorgungskonferenz berät den regionalen Versorgungsbericht und kann Empfehlungen zur Beseitigung oder Vermeidung regionaler Unterdeckungen beschließen.

(4) Bestehende gesetzliche Fachkonferenzen sollen einbezogen werden. Ihre Aufgaben können, soweit die jeweiligen gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden, gemeinsam mit der Grundversorgungskonferenz wahrgenommen werden. Zusätzliche Parallelgremien sind zu vermeiden.

§ 27

Landesgrundversorgungskonferenz

- (1) Die fachlich zuständigen Staatssekretariate berufen gemeinsam mindestens alle zwei Jahre eine Landesgrundversorgungskonferenz ein.
- (2) An ihr wirken insbesondere mit
 1. die Bezirke,
 2. die kommunalen Spitzenverbände,
 3. öffentliche und
gemeinwohlgebundene
Träger der betroffenen
Versorgungsbereiche,
 4. die Anstalt öffentlichen
Rechts „Gemeingut
Wohnen“,
 5. Interessenvertretungen der
Mieter,
 6. Interessenvertretungen der
Patienten,
 7. Interessenvertretungen der
Pflegebedürftigen und
pflegenden Angehörigen,
 8. Interessenvertretungen von
Menschen mit
Behinderungen,
 9. Gewerkschaften und
andere
Beschäftigtenvertretungen
sowie

10. die nach Bundesrecht für die sektorenübergreifende gesundheitliche und pflegerische Zusammenarbeit vorgesehenen Stellen, soweit deren Beteiligung rechtlich zulässig ist.

(3) Die Landesgrundversorgungskonferenz berät den Fachteil Soziale Grundversorgung nach § 1 und die Ergebnisse des Versorgungsmonitorings. Sie besitzt keine Entscheidungsbefugnisse gegenüber gesetzlich zuständigen Planungs- oder Selbstverwaltungsorganen.

§ 28

Nutzer- und Beschäftigtenbeteiligung

(1) Öffentliche, kommunale, genossenschaftliche und andere dauerhaft gemeinwohlgebundene Träger haben bei wesentlichen strukturellen Entscheidungen über Einrichtungen nach diesem Gesetz eine frühzeitige und angemessene Beteiligung der Nutzer und Beschäftigten sicherzustellen.

(2) Wesentliche strukturelle Entscheidungen sind insbesondere

1. dauerhafte Standortschließungen,
2. erhebliche Verminderungen des Leistungsangebots,
3. Zusammenlegungen von Standorten,
4. grundlegende Änderungen des Versorgungsauftrags und
5. Maßnahmen, die die Zugänglichkeit einer Einrichtung wesentlich verändern.

(3) Die Beteiligung ist so rechtzeitig durchzuführen, dass Stellungnahmen vor der abschließenden Entscheidung berücksichtigt werden können.

(4) Weitergehende gesetzliche oder satzungsmäßige Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten, Nutzer und betroffenen Gemeinden bleiben unberührt.

(5) Bestehende gleichwertige Beteiligungsorgane erfüllen die Anforderungen dieses Paragraphen. Insbesondere werden durch dieses Gesetz

keine parallelen
Beteiligungsorgane neben den
gesetzlich vorgesehenen
Organen der Anstalt öffentlichen
Rechts „Gemeingut Wohnen“
errichtet.

§ 29

Finanzierung und kommunaler Ausgleich

- (1) Maßnahmen des Freistaates nach diesem Gesetz stehen unter dem Vorbehalt der nach Maßgabe der Verfassung bereitgestellten Haushaltsmittel, soweit nicht die Verfassung oder dieses Gesetz eine unbedingte Leistungspflicht begründet.
- (2) Soweit Gemeinden, Landkreisen oder kreisfreien Städten durch dieses Gesetz neue oder erweiterte verpflichtende Aufgaben übertragen werden, ist ein finanzieller Ausgleich nach Maßgabe der Verfassung sicherzustellen.
- (3) Bestehende Finanzierungszuständigkeiten des Bundes, der Sozialversicherungsträger oder anderer Kostenträger dürfen nicht durch Landesmittel ersetzt

werden, soweit Bundesrecht dies nicht vorsieht.

- (4) Förderprogramme nach diesem Gesetz sind mit bestehenden Förderinstrumenten abzustimmen. Mehrfachförderungen desselben Zwecks sind auszuschließen, soweit nicht eine Kofinanzierung vorgesehen ist.

§ 30

Einsatz staatlicher Förder- und Sicherungsinstrumente

- (1) Bei bestehender oder drohender Unterdeckung hat die zuständige oberste Landesbehörde zu prüfen, welche vorhandenen rechtlichen, planerischen, finanziellen oder organisatorischen Instrumente geeignet sind, die Versorgung rechtzeitig zu sichern.
- (2) In Betracht kommen insbesondere
 1. Fachplanung und deren Fortschreibung,
 2. Investitions- und Strukturförderung,
 3. kommunale oder interkommunale Aufgabenerfüllung,
 4. Tätigkeit bestehender Landesanstalten und Landesunternehmen,

5. Tätigkeit öffentlicher oder gemeinwohlgebundener Unternehmen,
 6. vorhandene Fonds und Sondervermögen,
 7. Erwerb oder Bereitstellung von Grundstücken und Einrichtungen im Rahmen bestehender gesetzlicher Befugnisse und
 8. zeitlich begrenzte öffentliche Sicherungsmaßnahmen, soweit hierfür eine gesetzliche Grundlage besteht.
- (3) Neue dauerhafte Verwaltungsstrukturen, Anstalten, Unternehmen, Fonds oder Sondervermögen dürfen zur Erfüllung dieses Gesetzes nur geschaffen werden, wenn eine Prüfung ergeben hat, dass vorhandene Strukturen nicht geeignet sind.
- (4) Maßnahmen nach diesem Paragraphen sind mit dem Landesrahmenplan der öffentlichen Daseinsvorsorge und den für den jeweiligen Aufgabenbereich verbindlichen Vorgaben des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans nach Artikel 13b

der Ostdeutschen Staatsverfassung in Einklang zu bringen.

§ 31

Verordnungsermächtigungen

- (1) Das für die Wohnungswirtschaft zuständige Staatssekretariat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zu bestimmen über
1. die Indikatoren und Verfahren der Wohnraumbedarfsplanung nach § 7,
 2. die wohnungsbezogenen Mindestversorgungsstandards nach § 3,
 3. Form und Mindestinhalt kommunaler Wohnraumversorgungskonzepte nach § 9,
 4. das wohnungsbezogene Versorgungsmonitoring nach § 4 und
 5. Mindestanforderungen an die Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterkunft nach § 11 Absatz 2 und 3.
- (2) Das für Gesundheit und Pflege zuständige Staatssekretariat wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung das Nähere zu bestimmen über

1. die
Mindestversorgungsstandards für Gesundheit, Pflege, Gemeindepflege und öffentlichen Gesundheitsdienst nach § 3,
2. das Verfahren und die Datengrundlagen des Versorgungsmonitorings nach § 4,
3. Mindestinhalt und Verfahren der Pflegeinfrastrukturplanung nach den §§ 18 und 19,
4. die bedarfsgerechte räumliche Verteilung und Zusammenarbeit der Pflegestützpunkte nach § 20,
5. Mindestanforderungen an Angebote der Gemeindepflege nach § 21 und
6. das Verfahren nach den §§ 5 und 6.

- (3) Vor Erlass der Rechtsverordnungen sind die kommunalen Spitzenverbände, die Bezirke sowie die von der Regelung wesentlich betroffenen

Nutzer-, Träger- und Beschäftigtenvertretungen anzuhören.

Artikel 2

Erstmalige Planung und Übergangsbestimmungen

- (1) Der Fachteil Soziale Grundversorgung nach § 1 ist erstmals innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes als Teil des Landesrahmenplans der öffentlichen Daseinsvorsorge zu beschließen.
- (2) Die ersten regionalen Versorgungsberichte nach § 2 sind innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten der für das Versorgungsmonitoring maßgeblichen Rechtsverordnung nach § 31 vorzulegen.
- (3) Die ersten Pflegeinfrastrukturpläne nach § 18 sind innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes vorzulegen. Bereits vorhandene Planungen sind anzurechnen.
- (4) Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnungen nach § 31 werden bestehende

fachrechtliche Planungsmaßstäbe für das Monitoring zugrunde gelegt. Eine Unterdeckung kann bereits vor Erlass der Rechtsverordnungen festgestellt werden, wenn aufgrund fachgesetzlicher Planungsmaßstäbe eine erhebliche Gefährdung der Versorgung eindeutig feststeht.

Artikel 3 **Änderung des** **Gemeingut-Wohnen-Gesetzes**

Das Gesetz zur Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“ (Gemeingut-Wohnen-Gesetz – GWG) vom 23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 16) wird wie folgt geändert:

Dem § 2 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Anstalt wirkt im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben an der Erfüllung der Gewährleistungsverantwortung nach dem Soziale Grundversorgungsgesetz mit. Bei ihrer Investitions-, Neubau-, Erwerbs- und Bestandsplanung berücksichtigt sie die nach dem

Soziale Grundversorgungsgesetz festgestellten regionalen Wohnraumbedarfe. Die gesetzlich gewährleisteten Selbstverwaltungs- und Mitbestimmungsrechte der Anstalt bleiben unberührt.“

Artikel 4 **Änderung des Ostdeutschen** **Krankenhausgesetzes**

Das Ostdeutsche Krankenhausgesetz vom 15. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 752), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 51 S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 10a folgende Angabe eingefügt:

„§ 10b Verfahren bei regionaler Unterdeckung“.

2. Nach § 10a wird folgender § 10b eingefügt:

„§ 10b **Verfahren bei regionaler** **Unterdeckung**

(1) Wird nach § 5 des Gesetzes über die Gewährleistung von Wohnen, Gesundheit und Pflege für einen Krankenhausstandort oder Leistungsbereich eine bestehende oder drohende regionale Unterdeckung festgestellt, prüft die für die Krankenhausplanung zuständige Behörde unverzüglich, ob und in welchem Umfang der Krankenhausplan fortzuschreiben oder eine andere krankenhauserplanerische Maßnahme zu treffen ist.

(2) Die Prüfung erstreckt sich insbesondere darauf,

1. welche Krankenhausstandorte und Leistungsbereiche für die Deckung des festgestellten Bedarfs erforderlich sind,
2. ob bestehende Kapazitäten gesichert,

verändert oder miteinander verbunden werden können,

3. ob Maßnahmen nach § 10a

erforderlich sind und

4. ob die

Voraussetzungen

für ein Verfahren

nach dem

Ostdeutschen

Krankenhaussicherungs-

und

Rekommunalisierungsfondsgesetz

vorliegen können.

(3) Soweit Maßnahmen des Ostdeutschen

Krankenhaussicherungs- und

Rekommunalisierungsfonds

als geeignet erscheinen,

unterrichtet die

Krankenhausplanungsbehörde

unverzüglich die für

den Fonds zuständige

Stelle und übermittelt ihr

die für die Prüfung

erforderlichen Unterlagen.

(4) Die nach diesem Gesetz und dem

Krankenhausfinanzierungs-
gesetz zu beteiligten
Stellen sowie die
betroffenen kommunalen
Gebietskörperschaften
sind zu hören.

- (5) Die Prüfung soll innerhalb
von drei Monaten
abgeschlossen werden.
Bei einer unmittelbar
drohenden erheblichen
Beeinträchtigung der
stationären Versorgung
sind vorläufige
Sicherungsmaßnahmen
unverzüglich zu prüfen.“

Artikel 5

Änderung des Ostdeutschen Krankenhaussicherungs- und Rekommunalisierungsfondsgesetzes

Das Gesetz über einen Landesfonds zur
Sicherung und Rekommunalisierung von
Krankenhäusern im Freistaat
Ostdeutschland (Ostdeutsches
Krankenhaussicherungs- und
Rekommunalisierungsfondsgesetz –
OstKHFondsG) vom 23. März 2026
(OGVBl. 2026 Nr. 34) wird wie folgt
geändert:

1. § 13 Absatz 2 wird wie folgt
gefasst:

„(2) Das zuständige
Staatssekretariat kann ein
Verfahren von Amts wegen
einleiten, wenn Tatsachen
bekannt werden, die auf eine
erhebliche Gefährdung eines
versorgungsnotwendigen
Krankenhauses, Standortes oder
Leistungsbereiches schließen
lassen. Ist nach § 5 des Soziale
Grundversorgungsgesetzes eine
bestehende oder drohende
regionale Unterdeckung
festgestellt worden, die mit der
Gefährdung eines
Krankenhauses, Standortes oder
Leistungsbereiches
zusammenhängt, ist ein
Verfahren von Amts wegen
einzuleiten, sofern eine
Maßnahme nach diesem Gesetz
nicht offensichtlich ungeeignet
ist.“

2. Dem § 16 wird folgender Absatz
4 angefügt:

„(4) Begünstigte haben während
der Bindungsfrist bei
wesentlichen strukturellen
Entscheidungen, die den

Standort, die Zugänglichkeit oder das Leistungsangebot betreffen, eine frühzeitige und angemessene Beteiligung der Patienten- und Nutzerinteressen sowie der Beschäftigten sicherzustellen. Bestehende gesetzliche, kollektivrechtliche oder satzungsmäßige Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt. Gleichwertige bestehende Beteiligungsstrukturen erfüllen die Anforderungen des Satzes 1.“

3. § 18 wird wie folgt geändert:

- a) In der Bezeichnung wird das Wort „Landtags“ durch das Wort „Volkskammer“ ersetzt.
- b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das zuständige Staatssekretariat legt der Volkskammer jährlich einen Bericht über die Mittelverwendung, die geförderten Maßnahmen, die eingegangenen Beteiligungen, die Rückflüsse und die

wesentlichen Wirkungen des Fonds vor. Der Bericht stellt zusätzlich dar, in welchen Fällen Fondsmaßnahmen der Beseitigung oder Verhinderung einer nach dem Sozialen Grundversorgungsgesetz festgestellten regionalen Unterdeckung dienen.“

- c) In Absatz 3 wird das Wort „Landtag“ durch das Wort „Volkskammer“ ersetzt.

- 4. In § 20 werden die Wörter „Das für das Gesundheitswesen zuständige Staatsministerium wird im Einvernehmen mit dem für die Finanzen zuständigen Staatsministerium“ durch die Wörter „Das fachlich zuständige Staatssekretariat wird im Einvernehmen mit dem für die Finanzen zuständigen Staatssekretariat“ ersetzt.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Verkündung, frühestens jedoch an dem Tag in Kraft, an dem Artikel 1 des

Fünften Gesetzes zur Großen
Staatsreform zur Umsetzung des
Volkswillens in Kraft tritt.

Dresden, den 12. September 2026

Dr. Karl Honecker
Der STAATSPRÄSIDENT